PRIPREMA ZA ISPIT · SKRIPTA

Metodologija zdravstvenog obrazovanja i promocija zdravlja: suština za ispit

Svih 6 prezentacija (spec. sms Vesna Imbronjev; rasprava i debata: prof. dr Slađana Šimon), sa tabelom brojki, godina i autora na kraju.

Kako učiti iz skripte

Skripta pokriva svih 6 prezentacija iz predmeta „Metodologija zdravstvenog obrazovanja i promocija zdravlja" (VŠJ ICEPS): pet predavanja spec. sms Vesne Imbronjev i predavanje prof. dr Slađane Šimon o raspravi i debati. Izbačeni su naslovni slajdovi, slajdovi „Pitanja???" i ilustracije; ostalo je sve što može da se pita: definicije sa autorima, nabrajanja, faze, modeli, godine i brojke. Dva slajda u lekciji 6 imaju sadržaj samo u slici („Tri vrste rasprava" i redosled govornika u debati); i oni su prepisani. Skripta je upoređena i sa video predavanjima (Imbronjev: lekcije 1–3; Šimon: lekcija 6); ono što je rečeno, a nema na slajdovima, označeno je sa **„Iz predavanja"**.

1. Pročitaj jednu lekciju i odmah uradi njene testove.
2. Pitanja na kojima pogrešiš vrati u skriptu i podvuci.
3. Najviše se pita ono što je nabrojano i numerisano: aspekti zdravlja, 7 zdravih navika, 4 oblika zdravstvenog ponašanja, model zdravstvenog verovanja, ciljevi ZV (SZO, UNESCO), principi iz Otave, 5 faza programa, 9 faza PRECEDE-PROCEED. Sve brojke, godine i autori su skupljeni u odeljku „Brojke, godine i autori" na kraju.
4. Na kraju uradi simulaciju ispita (30 pitanja, 30 minuta).

#	LEKCIJA	AUTOR
1	Zdravlje i kvalitet života (uvodno predavanje)	Imbronjev
2	Zdravstveno ponašanje i zdravstveno vaspitanje	Imbronjev
3	Promocija zdravlja: definicija, ciljevi i dokumenti	Imbronjev
4	Planiranje i programiranje zdravstveno vaspitnog rada	Imbronjev
5	Zdravstveno vaspitne intervencije	Imbronjev
6	Razvoj stavova u raspravi i debati	Šimon

Skraćenice: ZV = zdravstveno vaspitanje; ZVR = zdravstveno vaspitni rad; ZVS = zdravstveno vaspitna sredstva; PZ = promocija zdravlja; PZZ = primarna zdravstvena zaštita; ZP = zdravstveni potencijal; KME = kontinuirana medicinska edukacija.

Lekcija 1: Zdravlje i kvalitet života

Uvodno predavanje, spec. sms Vesna Imbronjev. Definicija zdravlja, Millerova teorija sistema, dve dimenzije zdravlja, kvalitet života, aspekti zdravlja, modeli bolesti i 7 zdravih navika.

Definicija zdravlja

- **Ustav SZO:** zdravlje je „stanje potpunog fizičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i onesposobljenosti". *(Na slajdu tako piše; u punoj definiciji SZO iz 1946. stoji „fizičkog, psihičkog (mentalnog) i socijalnog blagostanja".)*
- Definiciju treba prihvatiti kao **idealni cilj** kome treba težiti, ali taj cilj **nema ograničeno vreme** za ostvarivanje.

Osnovi teorije zdravlja (Miller)

- Prema **Milleru**, životni sistem je **hijerarhija međusobno zavisnih delova**, u kojoj je viši nivo izgrađen od nižih podsistema.
- Individua je deo porodice, porodica deo lokalne zajednice, ona deo šire zajednice. Individua je i sama sačinjena od sistema (lokomotorni, cirkulatorni, digestivni), a oni od organa.
- U takvoj hijerarhiji **zdravlje je stanje dinamičke ravnoteže** ili proces koji održava tu ravnotežu na bilo kom nivou: organ, individua, porodica, zajednica.
- Dinamička ravnoteža zavisi i od sposobnosti individue ili grupe da uspostavi razumnu interakciju sa socijalnom, kulturnom, ekonomskom i tehničkom sredinom (razmena, komunikacija, rad, socijalne i političke odluke).
- Zdravlje je **dinamična karakteristika** individue, grupe ili socioekološkog sistema. Parametri (krvni pritisak, šećer u krvi, fiziološki zamor) stalno **osciliraju između višeg i nižeg limita** i menjaju se u ritmovima.
- Adaptirane individue održavaju unutrašnju ravnotežu, odnosno ostaju zdrave; poremećaji koji ne prelaze određeni nivo i trajanje mogu se tolerisati ili kontrolisati.
- Kada parametri pređu **najviši limit**, nastaje **stres**; ako duže traje, ozbiljan poremećaj. Ishod: ili **bolja adaptacija** na sredinu, ili **poremećaj sistema, odnosno bolest**.
- Da li će individua kontrolisati stres zavisi od stabilnosti odnosa organizma i sredine i od sposobnosti da utiče na novu situaciju. **Taj potencijal delovanja je veoma važan zdravstveni resurs.**
- Promene sredine često traže širu društvenu akciju. U razvijenim zemljama ona je usmerena na štetne navike koje su rizik za **masovne nezarazne bolesti**: neadekvatna ishrana, pušenje, nedovoljna fizička aktivnost. U zemljama u razvoju sprovode se aktivnosti za ublažavanje tih rizika.

Dve dimenzije zdravlja

	ZDRAVSTVENA RAVNOTEŽA	ZDRAVSTVENI POTENCIJAL (ZP)
Šta je	unutrašnje stanje izraženo kao **dinamički ekvilibrijum**	**sposobnost interakcije** pojedinca i spoljne sredine radi održavanja ekvilibrijuma ili njegovog ponovnog uspostavljanja kad se naruši
Pojedinac	utvrđuje se na osnovu **bioloških i psiholoških parametara**	dobar nutricioni status, imunološka otpornost, zdrav način života, sposobnost suprotstavljanja psihofizičkim stresovima
Zajednica	**epidemiološki indikatori**: stabilnost morbiditeta u periodu, veza nataliteta i mortaliteta, potreba i korišćenje zdravstvene službe	potrebne aktivnosti očuvanja ravnoteže; treba da bude deo socijalno-zdravstvene politike (mere unapređenja zdravlja, sprečavanja i suzbijanja bolesti)

Zdravstveni aspekti kvaliteta života

- **Kvalitet života** je širi pojam: pored zdravlja uključuje životni standard, kvalitet stanovanja, radne uslove itd.
- **Hipokrat (oko 400. g. p. n. e.):** zdravlje ili bolest proizilaze iz ravnoteže između faktora spoljne sredine (vetrovi, temperatura, voda, zemlja, hrana) i načina života (ishrana, piće, rad, rekreacija, seksualne aktivnosti). **Spoljna ravnoteža** čoveka i sredine određuje njegovu **unutrašnju ravnotežu**. Klinička praksa pomaže prirodnim snagama ozdravljenja, a javna zdravstvena zaštita predupređuje probleme zajednice (čovekov ekosistem).
- **Tradicionalna kineska medicina (pre oko 4.000 godina):** telo je sistem povezanih komponenti sa prirodnom težnjom ka ravnoteži; bolest nastaje narušavanjem ravnoteže zbog loše ishrane, nespavanja, nedovoljne fizičke aktivnosti, disharmonije u porodici i društvu.
- **Oba modela imala su ekološki okvir.**
- Otkrića o imunitetu dala su osnov za **prevenciju imunizacijom**; osetljivost i rezistencija postaju predmet kliničkog interesa, a psihosomatska medicina i epidemiologija šire biomedicinski pristup.
- Beda, slaba ishranjenost i fizička iscrpljenost mogu biti **stresogeni** i rizik za obolevanje. Od koje će bolesti osoba oboleti zavisi od **genetskih i stečenih konstitucionalnih faktora** i interakcije sa sredinom.
- **Socijalno-ekološki model** integriše biomedicinsku, psihosocijalnu i socijalno-medicinsku perspektivu.

Tri dimenzije u merenju zdravlja ili kvaliteta života (slaže se većina naučnika):

1. fizička funkcija;
2. psihološki status;
3. sposobnost uključivanja u normalne tokove društvene interakcije.

- **Život ima dve dimenzije: kvantitet** (broj godina života) i **kvalitet** (stanje od „perfektnog zdravlja" do „terminalnog stadijuma bolesti").
- **Merenje kvaliteta života** uključuje: fizičke funkcije, mentalno stanje, težinu oboljenja, socijalne funkcije i subjektivno osećanje zdravlja.
- **Funkcionalna merenja** su klinička ispitivanja kojima se procenjuje u kom obimu pacijent pod terapijom ili posle intervencije može da funkcioniše.

Zdravlje i faktori koji na njega utiču

- „Biti zdrav" ima različito značenje: za **laike** „ne biti bolestan", za **zdravstvenog radnika** „biti bez medicinski definisanih bolesti i nesposobnosti".
- **Aspekti zdravlja (5):** fizičko, mentalno, emocionalno, socijalno zdravlje i zdravlje zajednice.
- **Operativna definicija (stručna grupa SZO):** zdravlje je „stanje ili kvalitet ljudskog organizma izraženo adekvatnim funkcionisanjem organizma u datim uslovima, genetskim i spoljnoj sredini". U užem smislu: nema bolesti, osoba funkcioniše normalno prema opšteprihvaćenim standardima za pol, starost i geografsko područje, organi funkcionišu adekvatno; time se uspostavlja ravnoteža i stalnost unutrašnje sredine.
- **Glavni cilj preventivne medicine** je sprečiti pojavu i razvoj bolesti. **Bolest** je „nesposobnost adaptivnog mehanizma organizma da deluje adekvatno na stimuluse i stres kojima je izložen, što rezultuje poremećajem funkcionisanja ili strukture bilo kog dela, organa ili sistema tela". Ovo je **ekološki koncept bolesti** (veza organizma i sredine).

MODEL BOLESTI	ELEMENTI
Prvi: model trougla	uzročnik, domaćin, spoljna sredina; nastao proučavanjem **zaraznih** bolesti, primenjiv i na nezarazne
Drugi: model dijamanta	nezavisne, ali povezane varijable: genetski faktori, način života i ponašanje, socioekonomski faktori, pristupačnost i rad zdravstvene službe

- Zdravlje je **rezultat nasleđa i uticaja faktora sredine**. Preventivna medicina se dugo bavila štetnim faktorima sredine; prevencija abnormalnosti **genetskog porekla je novijeg datuma**.
- Nasledne osobine prenose se **stabilnim genima**, ali zračenje i lekovi mogu izazvati trajne promene, **mutacije**.
- Konstitucija i sredina ispitivane su kod **identičnih i neidentičnih blizanaca** za **TBC pluća**. Zaključak: prema konstituciji ljudi se svrstavaju u **3 grupe**:

GRUPA	OPIS	POTREBA
1	rezistencija veća nego kod drugih; obolevaju tek u nepovoljnim uslovima života i rada	nema potrebe za lečenjem
2	ne razbolevaju se pod normalnim uslovima	zdravstvene mere kad se normalni uslovi pogoršaju
3	razbolevaju se i pod normalnim uslovima	posebne mere i u normalnim uslovima

Zdravstvena služba i način života

- Zdravstvena služba je značajan faktor u prevenciji i kontroli bolesti, a ponekad i njena **determinanta (jatrogene bolesti)**. Kroz preventivno-promotivni rad, kurativu i palijativne mere obezbeđuje sve nivoe zaštite; od kvaliteta mera zavisi njen efekat na zdravlje.
- **Grci i Rimljani** smatrali su da zdravlje i bolest odražavaju **uslove života**. Proučavanje ishrane, alkohola, pušenja, fizičke aktivnosti, seksualnosti i reproduktivnog ponašanja skrenulo je pažnju na navike.
- **Lester Breslow i Alameda studija:** praćen je mortalitet u odnosu na „zdravu praksu" od **7 bazičnih navika**.

7 bazičnih zdravih navika (Alameda studija):

1. nikada nije pušio cigarete;
2. redovna fizička aktivnost;
3. umereno korišćenje ili nekorišćenje alkohola;
4. 7–8 sati redovnog spavanja;
5. održavanje odgovarajuće težine;
6. obavezan doručak;
7. bez jela između obroka.

- **Socijalna podrška:** ljudi sa rizičnim ponašanjima i slabom socijalnom vezom **ne žive dugo**.
- **Socioekonomska sredina:** obrazovanje, položaj u zanimanju, uslovi stanovanja, zagađenost (vode, vazduha, hrane).

- **Winslow:** „Narodno zdravlje je nauka i veština sprečavanja bolesti, produženja života i unapređivanja zdravlja i mentalne i fizičke vitalnosti pojedinaca, putem kolektivnog i organizovanog rada", čiji je cilj da sanira okolinu, bori se protiv bolesti od socijalnog značaja, uči pojedince ličnoj higijeni, organizuje lekarske i sestrinske službe za ranu dijagnostiku i blagovremeno lečenje i sprovodi mere koje svakom obezbeđuju životni standard povoljan za zdravlje. **Krajnji cilj:** da svaki pojedinac uživa svoje **urođeno pravo na zdravlje i dug život**.

Lekcija 2: Zdravstveno ponašanje i zdravstveno vaspitanje

spec. sms Vesna Imbronjev. Četiri oblika zdravstvenog ponašanja, model zdravstvenog verovanja, motivi i strah, definicije i ciljevi ZV, mesto ZV u prevenciji i indikatori zdravstvenog stanja.

Zdravstveno ponašanje

Svako ima svoje shvatanje zdravlja; teorije o zdravom i preventivnom ponašanju imaju praktičan značaj u ZV.

Zdravstveno ponašanje su oblici ponašanja i aktivnosti koje osobe preduzimaju sa svrhom:

OBLIK PONAŠANJA	SVRHA	KADA
Pozitivno zdravstveno ponašanje	unapređenje sopstvenog zdravlja	smatraju da su zdrave
Preventivno zdravstveno ponašanje	prevencija ili rana dijagnostika bolesti	smatraju da su zdrave ili zdravstveno ugrožene
Bolesničko ponašanje	utvrđivanje sopstvenog stanja i mogućnosti lečenja	smatraju se bolesnima
Ponašanje u ulozi bolesnika	ispunjavanje uputa i saveta o lečenju	„objektivno" je prihvaćeno da su bolesne

---

Model zdravstvenog verovanja (Health Belief Model)

- Postavio ga je **G. M. Hochbaum 60-ih godina**, a razradio **I. M. Rosenstock 1974.**
- Čovek polazi od **tri shvatanja**:

1. **Vlastita osetljivost:** subjektivna procena kolika je mogućnost da oboli; vodi do **„spremnosti da preduzme akciju"**.
2. **Ozbiljnost pretnje:** ocena opasnosti od narušavanja zdravlja („Koliko mogu biti ozbiljno bolestan?").
3. **Koristi i poteškoće:** poređenje koristi i očekivane „cene" aktivnosti (prepreke: emocionalne, fizičke, novčane). Najvažniji je subjektivni odgovor na pitanje **„Koliko se aktivnost isplati?"**

- **Hochbaum:** akcije su pod uticajem okolnosti i trenutka odluke, često su znak važnih i hitnih događaja, a **manje brige za zdravlje**. I kad mislimo da radimo nešto za zdravlje, razlozi su vezani za druge potrebe, navike, znanja i socijalni uticaj.

Motivi i strah

- Pozitivni motivi mogu se podudarati sa zdravstvenim razlozima, ali **oni nisu bitni**. Primer: pojedinac pere zube **da bi lepo izgledao**, ali i da bi sprečio karijes.
- Motivi se mogu **sukobljavati**: zna da je pregled koristan, ali se boji bolnosti pregleda. Sukob rešavamo **kompromisom**, obično u korist motiva koji osećamo kao važniji („Danas nemam vremena, ići ću drugi put").
- **Strah ima dvostruku ulogu:** odustajanje od pregleda može biti posledica straha da ne saznamo da smo teško bolesni. Kad se boje, ljudi **ne reaguju racionalno**: ili **negiraju opasnost** (veruju da važi za druge, ponašaju se kao da rizika nema) ili pokazuju **preteranu brigu, do panike**.

- **Učenje o zdravlju počinje u porodici:** pod uticajem roditelja dete stvara navike koje se razvijaju **ponavljanjem**, često vezane za zadovoljstvo ili nagradu. Odrastanjem na stavove utiču nova znanja, socijalni kontakti, zahtevi škole i posla i spoznaja da se starenjem pretnja za zdravlje povećava.

Zdravstveno vaspitanje: pojam i definicije

- **ZV je naučna disciplina** sa principima, teorijom i praksom. Zato je sadržajnije i efikasnije od **„zdravstvene propagande"** (širenje zdravstvenih informacija) i **„zdravstvenog prosvećivanja"** (popularizacija medicine), sa kojima ga mešaju oni koji ga ne poznaju.

> **Iz predavanja:** zdravstveno vaspitanje se naziva i **zdravstveno obrazovanje** (isti pojam).

AUTOR	DEFINICIJA ZV
Turner (na slajdu „Turne")	proces učenja koji proističe iz potreba za zdravljem, nastalih iz zdravstvenih znanja, a koji dovodi do razumnih, konstruktivnih i zdravih individualnih i društvenih postupaka
Wood	skup iskustava koja pozitivno utiču na navike, stavove i znanja u vezi sa zdravljem pojedinca, zajednice i čitave nacije
SZO	ne samo širenje informacija o zdravlju, već **aktivni proces učenja kroz iskustva**

- Za praktičnu primenu ZV potrebne su dobro organizovane, dostupne službe koje razumeju potrebe ljudi. To **ne podrazumeva moderno opremljene ustanove**, već zdravstvene radnike koji poznaju metodologiju rada sa ljudima.

Opšti ciljevi ZV (Komitet eksperata SZO):

1. učiniti zdravlje **cenjenom društvenom vrednošću**;
2. pomoći pojedincima da postanu **odgovorni za svoje zdravlje** i sprovode mere za puno zdravlje (u smislu definicije iz Ustava SZO);
3. unapređivati razvitak i **pravilno korišćenje zdravstvene službe**.

Specifični ciljevi (4): kognitivni, afektivni, bihevioralni, socijalni.

Mesto ZV u zdravstvenoj zaštiti

- SZO i **Deklaracija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti** stavljaju ZV u **prvi plan**.
- Mesto ZV je **prvenstveno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti**, ali je važno i u sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji. Potreba postoji kod **svih kategorija** stanovništva: zdravih, onih sa rizicima i bolesnih.

NIVO PREVENCIJE	ULOGA ZV	NAPOMENA
Primarna	aktivnosti očuvanja i unapređenja zdravlja kao bogatstva zdravog stanovništva; rad i sa osobama sa rizičnim ponašanjem (pušači, fizički neaktivni, gojazni), najčešće kroz **savetovališta**	mesta: (1) **porodica**, prvi formalni oblik za malu decu; ZV sprovodi **patronažna sestra**; (2) **škola**; (3) radna i životna sredina, lokalna zajednica

NIVO PREVENCIJE	ULOGA ZV	NAPOMENA
Sekundarna	interes da ljudi redovno kontrolišu zdravlje i prepoznaju simptome; brže izlečenje, bez komplikacija i recidiva	dejstvo **brzo i efikasno** jer je motivacija snažna, ali su **rezultati za zdravlje najslabiji** (oštećenje se ne može uvek vratiti)
Tercijarna	kod **rekonvalescenata**: izbeći invaliditet, komplikacije ili novi razvoj bolesti	osobe rado prihvataju ZV; rezultat je dobar ako usvojeno ponašanje zadrže i posle rekonvalescencije

Metodologija proučavanja zdravstvenog stanja stanovništva

- To je jedan od **osnovnih zadataka socijalne medicine**.
- Indikatori su **direktni** (morbiditet, mortalitet) i **indirektni** (o stanovništvu, socijalno-ekonomski i dr.).

12 indikatora za analizu zdravstvenog stanja: 1. brojno stanje; 2. natalitet; 3. fertilitet; 4. opšti i specifični mortalitet; 5. prirodni priraštaj; 6. očekivano trajanje života; 7. reprodukcija stanovništva; 8. morbiditet; 9. životni i radni uslovi; 10. nivo obrazovanja i zdravstvene svesti; 11. ekonomske mogućnosti; 12. uslovi za ostvarivanje i korišćenje zdravstvene zaštite.

- **Nijedan indikator sam za sebe** ne može biti osnov za ocenu zdravstvenog stanja.
- Indikatori iz **redovne statistike** nisu potpuno pouzdani, naročito za morbiditet i mortalitet prema uzroku.
- Za manje teritorije pogodna su istraživanja putem **ankete i skrininga**: daju sliku o **stvarnom, a ne samo „primećenom" morbiditetu**, rizičnim faktorima i korišćenju zaštite.
- **Registar određenih bolesti** (sa mortalitetom od njih) je **najpouzdaniji izvor podataka** za oboljenja koja su vodeći zdravstveni problem zajednice.

Dve strategije socijalne medicine: (1) oblikovanje jasnih ciljeva društvene politike u zdravstvu, na osnovu iskustva, tradicije borbe za narodno zdravlje, prava na zdravlje i društvene pravde; (2) **kritičko i objektivno istraživanje stvarnosti**.

Važni zadaci:

- osposobljavanje za objektivna i nepristrasna empirijska istraživanja radi predlaganja mera zdravstvene i socijalne politike;
- ublažavanje negativnih posledica liberalne politike, identifikacija zapostavljenih i ugroženih grupa, pomoć pojedincima i porodici, podrška dobrovoljnim i volonterskim organizacijama;
- razvoj i vrednovanje novih tehnologija za čuvanje zdravlja, uvođenje sistema unapređenja kvaliteta rada i trajno stručno usavršavanje;
- odgovori na nove etičke izazove u medicini, posebno prava čoveka-bolesnika.

Lekcija 3: Promocija zdravlja: definicija, ciljevi i dokumenti

spec. sms Vesna Imbronjev. Definicija i vrednosti promocije zdravlja, ciljevi ZV i PZ (SZO, UNESCO, globalni i uži), dokumenti SZO, Alma-Ata, Otava, Adelaida i ZV dijagnoza.

Definicija promocije zdravlja

- **Promocija zdravlja** je **proces učenja** kojim nastojimo da pojedinac ili zajednica **ovlada determinantama zdravlja**. Podrazumeva unapređenje zdravlja **pre nego što se pojavi bolest**.
- Za to treba menjati način života, sprovoditi zdravstveno informisanje, unapređivati životnu i radnu okolinu, jačati privredni razvoj i poboljšati socijalno-ekonomski status.
- PZ dodaje novu dimenziju radu zdravstvene struke: **odgovornost pojedinca i zajednice**.
- Izraz znači **„način razmišljanja u javnom zdravstvu"**; naglašava **zdravu politiku i promenu stila života** kao oruđe za bolje zdravlje.
- Važna je i uloga **„olakšavanja zdravih izbora"** (životna okolina, društveno učešće, mediji, škole, radne organizacije, lokalna samouprava).

Osnovne vrednosti promocije zdravlja (5):

1. etički principi;
2. poštovanje autonomije;
3. osposobljavanje pojedinca za rad;
4. briga za jednakost i socijalnu pravdu;
5. priznanje i poštovanje različitosti.

Ciljevi ZV i promocije zdravlja

Celokupna radnja ZV i PZ usmerena je na unapređenje telesnog, mentalnog i duševnog zdravlja i na društveno blagostanje.

Opšti ciljevi ZV prema dokumentima SZO (3): (1) da zajednica smatra zdravlje **visokom društvenom vrednošću**; (2) pomoći pojedincima da postanu sposobni i odgovorni za zdravlje, kao pojedinci i kao članovi grupe; (3) propagirati razvoj i ispravno korišćenje zdravstvene delatnosti.

Cilj promocije zdravlja (4):

1. smanjiti uzroke bolesti i onesposobljenja;
2. ohrabriti i podržati ljude da preuzmu odgovornost za svoje živote;
3. razviti javne politike koje štite i promovišu zdravlje i društveno blagostanje;
4. pomoći ljudima da steknu relevantne informacije i veštine o zdravlju.

Ciljevi ZV prema UNESCO-u (6) (vaspitna, naučna i kulturna organizacija UN):

1. pomoći ljudima da žive punim i srećnijim životom;
2. pomoći im da se prilagođavaju promenama u savremenom svetu;
3. ohrabriti ljude da razvijaju svoju kulturu;
4. omogućiti im ekonomski i socijalni napredak;
5. osposobiti ih da budu ravnopravni članovi savremenog sveta;
6. omogućiti svim ljudima da žive u miru.

Globalni ciljevi ZV i PZ (3):

1. učiniti zdravlje pojedinca i zajednice **najvećom društvenom vrednošću**, uz učešće pojedinaca, grupa i zajednice;
2. omogućiti ljudima da promocijom zdravlja **eliminišu razlike u zdravlju**;
3. politiku PZ **integrisati sa politikom drugih sektora** (stanovanje, rad, socijalne službe, PZZ).

Uži ciljevi ZV i PZ (4):

1. obavestiti sve ljude o zdravlju **u pravo vreme i na pravi način**, da razviju kulturu zdravog življenja;
2. **kolektivizirati** napore za postizanje zdravlja;
3. razviti **samopomoć (self-help)** i **samozaštitu (self-care)**;
4. razvijati zaštitu u kojoj **„medical care" prelazi u „health care"**.

Dokumenti SZO za promociju zdravlja

1. Konferencija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti u **Alma-Ati (SZO, 1978)**;
2. Strategija zdravlja za sve u Evropskom regionu (**1980**) i Evropski ciljevi zdravlja za sve (**1984, 1991**);
3. Dokumenti iz **Otave** o promociji zdravlja (**1986**);
4. Preporuke iz **Adelaide** za javnu politiku koja promoviše zdravlje (**1988**);
5. Preporuke iz **Beča** o zdravim gradovima (**1988**);
6. Evropski dokument o okolini i zdravlju (**1990**);
7. Izjava iz **Sundsvalla** o okolini koja pomaže zdravlje (**1991**).

Ideje iz završnog izveštaja konferencije u Alma-Ati (1978):

- zdravlje je **nezamenjiv preduslov** za društveni i ekonomski razvoj;
- razvoj nije samo rast, već i strukturalne i kvalitetne promene;
- na razvoj se najviše može uticati na **najnižem nivou, u lokalnoj zajednici**;
- PZZ omogućava: human odnos korisnika i davalaca usluga; kućnu negu i kućno lečenje u porodici; promotivno-preventivne aktivnosti u porodici.

Otavska strategija (1986): 5 principa

1. kreiranje javne politike koja promoviše zdravlje;
2. stvaranje pogodne sredine;
3. jačanje akcije u zajednici;
4. razvijanje ličnih sposobnosti;
5. reorganizacija zdravstvene službe.

Adelaida (1988): 4 prioriteta

1. podrška zdravlju žena;
2. zdrava ishrana;
3. suzbijanje uživanja duvana i alkohola;
4. stvaranje pogodne sredine.

Uloga zdravstvene promocije

Temeljne odrednice PZ su interventne mere na determinante zdravlja: genetski potencijal; zdrav razvoj deteta; sticanje znanja i pozitivnih stavova; razvoj zdravstvene službe; unapređenje radne i životne okoline; izrada i primena zakona; zdravstvena edukacija; promene javne politike.

Sistem PZZ treba da uključi: standardnu imunizaciju; usluge skrininga; zdravstvene provere i mere (promocija dojenja, bolnice-prijatelji dece, škole zdravlja); javno informisanje; savetovališta i podršku za prestanak pušenja, alkoholizma, prihvatanje dijetalne ishrane.

Zdravstveni radnici kao edukatori treba da poznaju: verovanja, ophođenja, tabue, običaje i druge kulturne fenomene (određene namirnice, nadrilekarstvo).

- **Zdrava osoba ne vodi brigu o zdravlju.** Da bismo je pridobili, oslanjamo se na neku njenu **osnovnu potrebu** (npr. prekid pušenja kod lečenja steriliteta).
- Metodologija ZV zasniva se na **postojećim interesima i potrebama** i na postojećem fondu znanja pacijenta ili grupe.
- ZV je **planirani uticaj na formiranje ponašanja**; znanje, stavovi, mišljenja i ponašanje određuju zdravlje.
- **Znanje i ponašanje** su dva važna faktora koja određuju zdravlje.

POJAM	DEFINICIJA
Znanje	„verovanje" čiju istinitost **možemo potvrditi, dokazati**
Mišljenje	„verovanje čija istinitost **nije uvek potvrđena**"

- Primer: mnogi znaju da je pušenje štetno, ali i dalje puše. Kad osoba oboli i bolest se komplikuje nezdravom navikom, motivacija za promenu je naglašena i ona prihvata promenu ponašanja.

Zdravstveno vaspitna dijagnoza

ZV dijagnoza za zajednicu i pojedince postavlja se na osnovu (5):

1. snimanja **znanja, stavova i prakse** ponašanja;
2. **statističkih izveštaja** o zdravstvenom stanju;
3. **prvih i ponovnih pregleda** (raširenost bolesti ili problema);
4. **ličnog uvida**;
5. **sondažnih istraživanja**.

Lekcija 4: Planiranje i programiranje zdravstveno vaspitnog rada

spec. sms Vesna Imbronjev. Pet faza programa, principi, sadržaji, metode (individualne i grupne), zdravstveno vaspitna sredstva, ZV u domu zdravlja, bolnici i zajednici, pristupi analizi i zdravstveni indikatori.

Osnove planiranja

- Osnovu planiranja i određivanja sadržaja ZV rada čine pre svega: podaci o **morbiditetu i mortalitetu**, opšti i populacioni podaci područja, higijensko-epidemiološka situacija, organizacija zdravstvene službe i mogućnost finansiranja.
- ZV je jedna od mera zdravstvene zaštite; ZV program treba da bude **deo programa zdravstvene zaštite** i da prolazi kroz iste faze.

Pet faza ZV programa

FAZA	NAZIV	SADRŽAJ
I	Snimanje osnove	upoznavanje zdravstvenih problema na teritoriji i faktora koji utiču na zdravlje; pored rutinske statistike, **ankete** stanovništva, zdravstvenih i prosvetnih radnika
II	Analiza podataka i izdvajanje prioriteta	postavlja se **„dijagnoza" zdravstvenog stanja** i definišu problemi vezani za stepen ZV; to je putokaz za program, metode i mere
III	Izrada programa	svaki program je **specifičan** (problemi ciljnih grupa, sadržaji)
IV	Izvođenje programa	učestvuju **svi zdravstveni radnici i saradnici iz zajednice** (roditelji, prosvetni radnici, aktivisti mesne zajednice, sportisti)
V	Evaluacija	ocena postignutog u odnosu na ciljeve, prema utvrđenim kriterijumima; vrši se **tokom** sprovođenja i **na kraju**

U III fazi svaki program razrađuje (7): 1. sadržaj i metodologiju rada; 2. edukativne jedinice i obim delovanja; 3. vremenski okvir; 4. kadrove i njihovu edukaciju; 5. zdravstveno vaspitna sredstva; 6. finansijska sredstva; 7. elemente za evaluaciju.

Shema na slajdu: demografski podaci → istraživački rad, zdravstvena politika i ZV program → revizija → evaluacija i realizacija.

Principi ZV programa (5)

1. ZV program je **osnova za planiranje, programiranje i ugovaranje** ZV rada na području.
2. **Nosilac** ZV programa u našoj sredini je **zdravstvena služba**, uz aktivno uključivanje saradnika iz zajednice.
3. Program mora predvideti sadržaj, metodologiju i ZV sredstva za sve učesnike, imajući u vidu prioritetne probleme.
4. Program mora predvideti **sve učesnike** u realizaciji i oblike njihove edukacije.
5. Sadržaji se razlikuju prema **potrebama sredine** i populacije na koju program deluje.

Najčešći sadržaji programa: zdravlje porodice; zdrava životna sredina; ishrana; human odnos među polovima; međuljudski odnosi i mentalno zdravlje; povrede; faktori rizika; odnos zdravstvenog radnika i pacijenta; zaštita od bolesti.

Metodološki postupci

- ZV **nije samo sebi cilj**; zasniva se na poznavanju zdravlja, uzroka bolesti i invalidnosti i na poznavanju ljudi (kultura, način života, verovanja, tradicija, običaji, vrednosti, moral, zabrane, ciljevi). Sve to je potrebno da bi se otkrio **najadekvatniji motiv**; za svaku grupu i individuu treba otkriti **pravu motivaciju**.
- **Metode ZV rada** su tehnike i postupci rada sa pojedincem ili grupom kojima se menjaju znanja, stavovi i navike. Dele se na **individualne** i **grupne**.

Individualne metode: intervju

- **Intervju** je razgovor **dve osobe** koji ima **definisanu svrhu**.
- Princip: najpre se **prouči i pridobije** intervjuisana osoba, pa je tek onda podvrgnemo vaspitnom procesu. Može se voditi u domu zdravlja, bolnici, kućnoj poseti.
- **Planirani intervju** je jedna od najvažnijih metoda rada sa ljudima. **Prvi kontakt je presudan**; važan je empatijski odnos.
- **Empatija** je razumevanje osećanja, briga i potreba **bez identifikacije** sa ličnošću pacijenta.

Grupne metode

- Potreba za **pripadnošću grupi** usmerava postupke pojedinca pozitivno ili negativno; želi da bude prihvaćen, a plaši se odbacivanja, pa usvaja stavove i vrednosti grupe. U ZVR koristi se uticaj **grupa istih interesa i potreba**.

	MALA GRUPA	VELIKA GRUPA
Veličina	**10–15** osoba	**30 i više** članova
Sastav	**homogena po ciljevima** (odvikavanje od pušenja, oboleli od šećerne bolesti); može biti produktivna i kad članovi nemaju isti nivo obrazovanja	predavanja, konferencije, panel diskusije, dramske predstave
Uloga zdravstvenog radnika	**stručni konsultant, savetnik**	predavač, moderator

Rad u maloj grupi:

- grupa ima svoju organizaciju; bira **predsednika** (koji uživa poverenje svih) i **posmatrača** (prati rad);
- dugim radom mišljenja se približavaju, a stručni ton daje zdravstveni radnik; planiraju se aktivnosti koje će naići na odobravanje okoline;
- **diskusija je prvi vid aktivnosti** u grupi i prethodi grupnoj odluci;
- male grupe rešavaju probleme zajednice (odvikavanje od pušenja, povišen pritisak, astma).

Velika grupa:

- **Predavanje** je **najčešći oblik** rada velike grupe; više je pružanje informacija i prosvećivanje. Predavač vlada veštinom govora, priča razumljivo i poznaje materiju.
- **Priprema predavanja:** (1) upoznavanje sa materijom; (2) upoznavanje grupe; (3) izbor nekoliko interesantnih pitanja koja podstiču diskusiju; (4) izlaganje **do 15 minuta**, da ostane vreme za diskusiju.
- Predavanje je **izuzetno pasivan model**, pa se uvodi diskusioni sastanak **„pitanja i odgovori"**: radnik odgovara, upoznaje auditorijum i podesne osobe za malu grupu.
- **Tehnika Phillips (Philips):** posle uvodnog predavanja velika grupa se deli na **6 malih grupica** koje diskutuju po **6 minuta**; zatim referenti grupa iznose zaključke.
- **Panel diskusija:** stručnjaci o jednoj temi ispred auditorijuma; organizuje se kad su **stavovi podeljeni**; grupa stručnjaka započinje, a **moderator** povezuje auditorijum sa njima; preko TV-a, radija, novina dobija širok publicitet.
- **Dramske predstave** (skečevi, kratki komadi, lutkarske predstave) naročito kod **dece**.
- **Životna demonstracija:** učenje **kroz iskustvo**, na licu mesta uz zdravstvenog konsultanta; za malu i veliku grupu; u školi, ustanovi, porodici; **vaspitni efekat je velik**.

Dvostruki put obrazovanja: Sokratovska metoda

- Svodi se na **diskusionu grupu**. Pretpostavlja da ljudi već imaju informacije, osećanja, interese i uverenja, koje treba uzeti u obzir pre nego što ih menjamo.
- **Oblici:** diskusione grupe (dijalog); komisije za zdravlje, panel diskusije; savet za zdravlje; intervju zdravstvenog tipa; drame sa zdravstvenim sadržajem (zdravstveno pozorište); životne demonstracije (vikend seminari); izmišljene situacije i **igranje tuđe uloge**.
- Omogućavaju razmenu informacija među korisnicima i **povratnu informaciju**.

Zdravstveno vaspitna sredstva (ZVS)

- **Dvostruka uloga:** pomažu **vaspitaču** u radu i pomažu **ljudima** da lakše shvate i prihvate poruku.
- Deluju na jedno čulo (vid, sluh, dodir) ili su **kombinovana** (više čula).

VRSTA	PRIMERI I NAPOMENE
Očigledna: izložbe	u bolnicama, savetovalištima, čekaonicama; uz vizuelni može i zvučni efekat
Pokretne slike	**film** (vid i sluh); zdravstveni filmovi su kratkometražni, **12–45 min**; **video traka** jeftinija, može se više puta snimati i brisati
Nepokretne slike	**dijafilm** (niz slika na filmskoj traci, dijaprojektor); **album** (slike za jednu temu: povijanje bebe, nega stome)
Štampana	plakati, slikovnice, flajeri, agitke, knjige, brošure; šire krugu ljudi daju objašnjenje i podsećaju na savete (primeri na slajdu: „Život DA, droga NE", samopregled dojki)
Prenošenje žive reči	magnetofon, gramofon, danas snimci mobilnim telefonom; reprodukcija nezavisno od vremena i mesta
Masovna komunikacija	radio, razglas, TV, štampa, telefonske informacije, bioskop, YouTube, internet, društvene mreže; dopiru do miliona, ali mogu i **obmanuti** neosnovanim informacijama

Vežba sa slajda: napravi plakat ili obaveštenje za tribinu/predavanje o aktuelnom zdravstvenom problemu.

ZV u zdravstvenim ustanovama i zajednici

- ZV u ustanovama je **obaveza (stručna, etička, zakonska)** svih zdravstvenih radnika i ustanova.

ZV u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (dom zdravlja) je **obavezni deo programa** zaštite i podrazumeva:

- poznavanje zdravstvenih prilika na području i faktora koji utiču;
- poznavanje uzroka problema, načina rešavanja, interesa i potreba korisnika;
- informisanje i vaspitanje stanovništva za očuvanje zdravlja, zaštitu, rano otkrivanje, lečenje, rehabilitaciju i resocijalizaciju.
- Svaki pregled (prvi, kontrolni, sistematski), a naročito rad u **savetovalištima i patronaži**, pruža mogućnost za ZV. Škole za trudnice, savetovališta za dijabetičare; saradnja sa mesnim zajednicama, **Crvenim krstom**, školama i socijalnim ustanovama.

ZV u bolnici: pogodnosti: (1) bolesnici su **visoko motivisani**; (2) **blizak odnos** sa zdravstvenim radnicima. Svaki kontakt (anamneza, vizita, procedure) koristi se za informacije. Bolesnicima je često **dosadno**, pa se to vreme koristi za **okupacionu terapiju** i ZV edukacije.

ZV u zajednici: zajednica je grupa ljudi u bliskom kontaktu koje vezuju zajednički interesi i želje. Cilj je da zajednica shvati **zdravlje kao najviši cilj** i usmeri snage na zdravlje svih, kroz **odgovornost za sopstveno zdravlje i zdravlje zajednice**.

1. Zdravstvena služba izlazi iz svojih okvira; radnici u timu sa drugim stručnjacima i stanovnicima analiziraju probleme, ciljeve, prepreke i mogućnosti (kadrovske, organizacione, finansijske) i donose plan; preko medija pridobijaju javno mnjenje.
2. Zajednica se uključuje preko formalnih struktura (skupštine, opštine, sekretarijati).
3. U porodici se stvaraju uslovi za ZV deteta, škola ga dopunjava; mesna zajednica kroz zaštitu sredine, masovne akcije ranog otkrivanja bolesti i sportske aktivnosti.
4. Cilj: **da zdravo ponašanje bude i društveno ponašanje**.

Izvori podataka: redovna statistika (nije potpuno pouzdana za morbiditet i mortalitet po uzroku); za manje teritorije **ankete i skrining**; **registar bolesti je najpouzdaniji izvor** za vodeće probleme; korišćenjem svih izvora dobija se realnija slika.

Individualni i socijalno-medicinski pristup analizi zdravstvenog stanja

	INDIVIDUALNI (KLINIČKI) PRISTUP	SOCIJALNO-MEDICINSKI PRISTUP
Cilj	lečenje obolelog	unapređenje zdravstvenog stanja
Informacije	anamneza, fizikalni pregled, laboratorija, testovi	podaci o stanovništvu, morbiditetu, mortalitetu, faktorima rizika, zdravstvenoj službi
Dijagnoza	diferencijalna, definitivna	dijagnoza zdravstvenog stanja zajednice, izbor prioriteta
Akcioni plan	praćenje i merenje	evaluacija promena zdravstvenog stanja

- Pokazatelji zdravlja pojedinca ne odražavaju jednu dimenziju, već **globalno stanje** pozitivnih i negativnih aspekata socijalne, mentalne i fizičke komponente.

Tri pitanja u planiranju:

PITANJE	ŠTA ZAHTEVA
1. Gde želimo da budemo? („TAMO")	nacionalni programi i planovi sa globalnim i specifičnim ciljevima
2. Gde smo sada? („OVDE")	procena zdravstvenog stanja stanovništva
3. Kako od „OVDE" do „TAMO"?	izbor alternativnih strategija sa najvećim efektom uz postojeće resurse

Ciklus planiranja (shema): stanovništvo/spoljna sredina → sakupljanje podataka → produkcija zdravstvenih informacija → procena zdravstvenog stanja → procena problema i bolesti → izbor prioriteta → postavljanje ciljeva → izbor alternativnih intervencija → implementacija programa → evaluacija efikasnosti → unapređenje zdravstvenog stanja.

Zdravstveni indikatori

- **Indikatori** su merila kojima se **mere promene** tokom vremena; većina je **kvantitativna**, neki kvalitativni. Potrebni su da bi se: analizirala sadašnja situacija, pravile kampanje, merile promene.

KATEGORIJA	PRIMERI
1. Indikatori zdravstvene politike	politička podrška, vlast, raspodela sredstava za zdravlje
2. Socijalno-ekonomski	nacionalni dohodak (BND) po stanovniku, pismenost, ishrana, zaposlenost, stanovanje
3. Obezbeđenosti zdravstvene zaštite	pristupačnost doma zdravlja, bolnica, opreme i obuhvat **8 bazičnih elemenata PZZ**
4. Zdravstvenog stanja	nutritivni status (procenat dece sa blagom, umerenom i teškom malnutricijom), mortalitet, morbiditet, fizičko, socijalno i mentalno blagostanje kroz **sopstvenu procenu zdravlja**

8 bazičnih elemenata PZZ: zdravstveno vaspitanje; obezbeđenost hranom; zdrava pijaća voda i odgovarajuća dispozicija otpadnih materija; zdravstvena zaštita majke i deteta i planiranje porodice; imunizacija; prevencija i kontrola endemskih bolesti; odgovarajući tretman najčešćih bolesti i povreda; obezbeđenost lekovima.

Lekcija 5: Zdravstveno vaspitne intervencije

spec. sms Vesna Imbronjev. Modeli intervencija, 9 faza PRECEDE-PROCEED, mesta i kadrovi, problemi koji se rešavaju ZV i CINDI program.

Modeli zdravstveno vaspitnih intervencija

FAZA	PRECEDE-PROCEED, GREEN (1991)	MHEP, ROSS I MICO (1980)	CHEM, SULLIVAN (1973)	MHERPD, BATES I WINDEN (1984)	CHEDS, PATTON (1986)
1	socijalna dijagnoza	početna	uključivanje ljudi	ZV planovi	procena potreba
2	epidemiološka dijagnoza	procena potreba	postavljanje ciljeva	demonstrativni programi	postavljanje cilja
3	dijagnoza ponašanja i uticaja okoline	postavljanje cilja	definisanje potreba	programi operacionalizacije	planiranje
4	edukativna i procesna dijagnoza	planiranje i kreiranje programa	dizajniranje plana	istraživački programi	implementacija programa
5	administrativna politika i dijagnoza	implementacija	sprovođenje aktivnosti	informacije i statistika	evaluacija
6	implementacija	evaluacija	evaluacija rezultata	proces evaluacije	edukativna komponenta
7	procesna evaluacija			ostali različiti procesi	servisna komponenta
8	evaluacija uticaja				
9	evaluacija posledica (ishodna)				

PRECEDE-PROCEED model (9 faza)

Najpoznatiji model u promociji zdravlja; primenu programa posmatra kroz **9 faza**:

1. **Socijalna dijagnoza:** procena **socijalnih potreba**; podaci anketom, ličnim uvidom i drugim aktivnostima, da se razume zajednica.
2. **Epidemiološka dijagnoza:** utvrđuju se zdravstveni problemi, njihova **raširenost** i faktori koji joj doprinose.
3. **Dijagnoza ponašanja i okoline:** faktori socijalnog i fizičkog okruženja uzročno povezani sa ponašanjem ili posledicama za kvalitet života.

4. **Obrazovna (organizatorska) dijagnoza:** ispituju se **razlozi ponašanja**; najvažnije je identifikovati faktore koje treba promeniti; oni su **neposredni ciljevi** programa.
5. **Administrativna i politička dijagnoza:** analiza **političkih resursa** i okoline koji mogu pomoći ili otežati intervenciju.
6. **Implementacija** intervencije.
7. **Procesna evaluacija:** počinje često **odmah sa implementacijom**; procenjuju se **prvi efekti** na poželjno ponašanje.
8. **Evaluacija uticaja: trenutni efekti** programa na ciljano ponašanje ili faktore okoline.
9. **Ishodna evaluacija:** uvid u **zdravstvene indikatore**; **završna faza**, sa svim parametrima evaluacije.

- **Proste informacije nisu dovoljne** za promenu ponašanja; ljude treba naučiti kako da ih primene. Upozorenje na kutijama cigareta („pušenje skraćuje život") ne obeshrabruje pušače, ali onima koji žele da prestanu treba pomoći, npr. kroz **Petodnevni program odvikavanja od pušenja**.
- Program deluje na povećanje **fonda znanja, motivacije i veština**.

Mesta izvođenja ZV i promocije zdravlja

ZV i PZ obavljaju se **na svakom mestu**: porodica; zdravstvene ustanove primarne, sekundarne i tercijarne zaštite; predškolske ustanove; škole i obrazovne institucije; radni kolektivi; naselja i klubovi; domovi za stara lica i za decu; udruženja i verske organizacije.

- **Osnovna dužnost zdravstvenog edukatora** je da promoviše zdrav način življenja.
- **Posebne ciljne grupe:** deca i omladina, grupe odraslih, hronični bolesnici, migranti i raseljena lica.

Kadrovi u zdravstvenom obrazovanju

- **Obaveza svih zdravstvenih radnika** je da sprovode zdravstveno prosvećivanje; danas postoje i **specijalisti** za zdravstveno obrazovanje i PZ.
- Doprinose i studenti i nastavnici medicinskih i pedagoških škola, članovi UN i NVO, aktivisti, sociolozi, inženjeri zaštite na radu, pravnici, ekonomisti.
- Važe principi o **ličnim kvalitetima edukatora**, bez obzira da li je profesionalac.
- U zdravstvenim, socijalnim i obrazovnim ustanovama **prioritet imaju zdravstveni profesionalci**.
- Osposobljavanje: redovno školovanje, diplomske i postdiplomske studije, specijalizacije, master, seminari i **KME**.
- Treba stalno pratiti **društvena zbivanja** i povezivati rad sa razvojem društva.

Problemi koji se rešavaju zdravstvenim obrazovanjem

- Velika je potreba za edukacijom: preti ne samo zarazne, već i **masovne nezarazne bolesti**. ZV, promotivni programi i zdravstvena propaganda postaju **moćno oružje** protiv obolevanja, smrtnosti i invalidnosti.
- Pored genetskih postoje i spoljašnji faktori; nezdravo, **sedentarno** življenje je problem kao i zagađenost vazduha i vode, zaštita od zračenja.

Problemi (9): 1. ishrana; 2. voda; 3. upravljanje krupnim otpadom; 4. posttraumatski stres; 5. zdravlje mladih; 6. zdravlje lica trećeg životnog doba; 7. zdravlje žena i kontrola reproduktivnog zdravlja; 8. masovne nezarazne bolesti; 9. palijativna nega.

CINDI program

- **1982:** Evropska regionalna kancelarija SZO počela je da razvija globalni program prilagođen lokalnim interesima, sa ciljem zdravlja **do 2000. godine**; zatim se razvija **CINDI** program za **prevenciju masovnih nezaraznih bolesti**.
- **1986:** u bivšoj Jugoslaviji počinje u **Beogradu, Ljubljani i Novom Sadu**; nosilac je bio **DZ „Novi Sad"**.
- Projekat je sveobuhvatna zaštita od rizika za **hronične masovne nezarazne bolesti**.
- **Cilj:** kod dece i omladine što ranije **sprečiti sticanje navika** koje su faktori rizika; kod odraslih **izmeniti loše navike**.
- Učestvuju: zdravstvena služba, prosvetno-pedagoške ustanove, mesne zajednice, političke, socijalne i humanitarne organizacije, radni kolektivi, mediji, vladine i nevladine organizacije. Zdravstveni radnici se osposobljavaju kroz **KME**.

Značaj CINDI programa: kod svakog pacijenta se utvrđuju faktori rizika:

- faktori rizika se ocenjuju **u istom vremenskom periodu** za sve ispitanike;
- radi se po **metodologiji SZO**;
- mogu se edukovati svi zdravstveni radnici; lako se primenjuje u **timu izabranog lekara** uz saradnju lokalne zajednice.

Mere u okviru CINDI programa:

- Primarna prevencija počinje u **savetovalištima za trudnice** (nega, ishrana, odmor); rade stomatolozi, ginekolozi i izabrani lekar sa **patronažnom sestrom**. **Škole za trudnice** edukuju oba bračna partnera.
- **UNICEF bolnice, „bolnice prijatelji dece"**: beba se stavlja na podoj **pola sata posle rođenja**. **Promocija dojenja** je sastavni deo projekta.
- Deca **do 3 godine**: savetovališta u PZZ; uz pedijatra i ginekologa i stomatolozi rade sa roditeljima u kući.
- Škole: ZV po tematskim područjima prema uzrastu; roditelji takođe. U starijim razredima programi **„Škole zdravlja"**; ZV i tokom **sistematskih pregleda**.
- **Kvizovi znanja, tribine, igrokazi**: mladi odgajaju mlade (**PIER grupe**, vršnjačka edukacija).
- Mesne zajednice: predavanja o vodećim uzrocima oboljenja (kardiovaskularne, maligne, respiratorne, šećerna bolest), posete demonstracionim područjima, kuhinjama, oglednim dobrima.
- ZV u **radnim organizacijama**; čekaonice, savetovališta, centri za porodicu, savetovališta za mlade i **Preventivni centri**.
- Rad **koordinira Odbor za zdravlje**, u saradnji sa medijima i pisanom zdravstvenom propagandom.
- **Evaluacija:** tokom rada po fazama, ciljana istraživanja, ankete dece, omladine i odraslih; meri se **incidencijom i prevalencijom** masovnih nezaraznih bolesti pre i posle programa i **zadovoljstvom korisnika**.

Lekcija 6: Razvoj stavova u raspravi i debati

Prof. struk. studija dr Slađana Šimon. Stav, rasprava, tri vrste rasprava, debata, argumentacijske linije, priprema argumenata, Karl Popperova debata, primer i značaj debate.

Stav

- **Stav** je socijalizacijom stečena, **relativno trajna mentalna dispozicija**, koja se ispoljava kao tendencija da se **misli, oseća i postupa** na određeni način.
- Odlike: dublje psihološke strukture; oseća se kao **pozitivna ili negativna** reakcija; unutrašnja psihološka dispozicija; **afektivan** (dopadanje ili ne); **globalna, trajna orijentacija** prema generalnoj klasi pojava.

Rasprava

- **Rasprava** je oblik verbalne komunikacije u kome sagovornici imaju **suprotna ili drugačija mišljenja o istom pitanju**. Raspravlja se **uvek o nekoj tvrdnji**.
- **Zašto rasprava:** razvija **kritičko, logičko i kreativno razmišljanje** zasnovano na argumentima i dokazima; podrazumeva istraživanje tema, uverljivo zastupanje stavova, otvorenost za različitosti, slušanje sa razumevanjem i **uljudno „napadanje"** suprotnih stavova.

Tri vrste rasprava (slajd u slici):

VRSTA	PRAVILA I VODITELJ	KO POBEĐUJE
Svađa	bez pravila ponašanja i bez voditelja	pobeđuje **jači**
Okrugli sto	voditelj zna pravila i vodi raspravu (najavljuje govornike, daje i uzima reč)	o pobedniku odlučuje **publika**
Debata	bez voditelja; **svi učesnici znaju pravila**	**sudija** odlučuje ko je pobednik

> **Iz predavanja:** tri vrste rasprava razlikuju se po tome **da li postoje pravila ponašanja, da li učestvuje sudija i da li je prisutna publika**.

Debata

- **Debata** je **strukturisana argumentovana rasprava** (različiti formati).
- **Argumenti** su rečenice kojima pokušavamo da dokažemo (ili osporimo) istinitost **teze**.
- Raspravlja se o određenoj tvrdnji, **tezi**; o vrednosnim tvrdnjama, uverenjima i stavovima; obrazlažu se razlozi **ZA i PROTIV**.

Struktura debate:

AFIRMACIJSKA LINIJA: DOKAZATI TEZU	NEGACIJSKA LINIJA: NEGIRATI TEZU
1. definisati ključne reči	1. prihvatiti definiciju (ili ponuditi svoju)
2. postaviti i opravdati kriterijum	2. prihvatiti kriterijum (ili ponuditi novi)

AFIRMACIJSKA LINIJA: DOKAZATI TEZU	NEGACIJSKA LINIJA: NEGIRATI TEZU
3. dati argumente u prilog tezi, u skladu sa definicijom i kriterijumom	3. dati argumente koji pobijaju tezu, u skladu sa kriterijumom i definicijom
4. pobijati argumente negacije i osnaživati svoje	4. pobijati argumente afirmacije i osnaživati svoje
5. suočiti obe linije ističući prednosti afirmacije	5. suočiti obe linije ističući prednosti negacije

Koraci pripreme argumentacijske linije (6):

1. svako donosi ideje, stavove, znanja (**„oluja mozgova"**);
2. prikupljanje što više relevantnih činjenica i predstavljanje grupi;
3. vrednovanje iskoristivosti podataka;
4. grupisanje i imenovanje argumenata;
5. određivanje kriterijuma;
6. organizovanje argumenata u sled.

Zlatno pravilo iznošenja argumenata: reci o čemu ćeš govoriti (uvod); govori (razrada); reci o čemu si govorio.

- **Ključ je u argumentima:** dobar javni nastup daje dodatnu snagu, ali **ključ uspeha su dobro izvedeni argumenti**. Debateri često zastupaju stavove koji im nisu bliski, pa je ključ u **kvalitetnoj pripremi**.

Karl Popperova debata (forma)

- **Dve ekipe, svaka po tri člana.**
- Svaki govornik ima svoju govorničku ulogu; vreme govora je **ograničeno**; svaka ekipa može koristiti određeno vreme za razmišljanje; **sudija donosi presudu**.

> **Iz predavanja:** Karl Popperova debata je **najpoznatija forma debate**. Po principu **jednakosti**, svaka ekipa ima **jednako vreme** da izloži argumente. Uvodni govor (90 s) je najduži deo.

Redosled govora (slajd „Metodologija", u slici):

#	GOVORNIK I ULOGA	TRAJANJE
1	afirmacijski govornik: uvodni govor	90 s
2	negacijski govornik napada pitanjima	60 s
3	negacijski govornik: uvodni govor	90 s
4	afirmacijski govornik napada pitanjima	60 s
5	afirmacijski govornik: završni govor	45 s
6	negacijski govornik: završni govor	45 s

Primer debate

Teza: „Treba uvesti seksualno obrazovanje kao obavezan predmet u škole u Srbiji."

Definicije: seksualno obrazovanje = informisanje i komunikacija o ljudskoj seksualnosti s fizičkog i psihičkog aspekta i promovisanje moralnih vrednosti; obavezan predmet = predmet koji pohađaju svi učenici; OŠ = ustanova koju obavezno pohađaju deca **od 6 do 15 godina**.

	VARIJANTA 1	VARIJANTA 2
Afirmacija: argumenti	informisanost; očuvanje zdravlja; promovisanje tolerancije	pravo na znanje; priprema za zreliji život; komunikacija i prevencija
Afirmacija: kriterijum/cilj	razvoj pojedinca do kvalitetnog života u društvu	postizanje seksualne zrelosti
Negacija: argumenti	pravo na izbor; različiti izvori informacija; nedelotvornost programa	pravo na izbor; uloga porodice; drugačiji način
Negacija: kriterijum/cilj	slobodan razvoj mladih u zajednici	postizanje zrelosti kroz porodicu

Vežba „Jedna reč je dovoljna"

- **Cilj:** podstaći učesnike da razumeju i istaknu **bitno** i brinu o zadatom vremenu.
- **Forma:** A1 2 min, N1 2 min; A2 1 min, N2 1 min; A3 ½ min, N3 ½ min; A4 jedna rečenica, N4 jedna rečenica; A5 **jedna reč**, N5 jedna reč.

Šta se procenjuje u govoru: sadržaj i **prezentacija** (organizacija govora i način izvođenja govora).

> **Iz predavanja:** važno je da govornik bude **siguran u sebe i ubedljiv**.

Značaj debate

- **Edukativna komponenta:** svaka tema može se posmatrati **višeznačno**; učesnici šire bazu saznanja; razvijaju se kognitivne strategije zasnovane na **kritičkom mišljenju** (sagledavanje, analiza, rešavanje problema, argumentacija).
- **Civilizacijski iskorak u razmeni mišljenja:** nema prekidanja govornika, zamene teza, beskrajnih monologa, paušalnih ocena, uvreda i nasilja; **sudije cene argumente i način prezentacije** i paze na pravila.
- **Model nenasilne komunikacije:** vrednosti razvijenih demokratija lakše se primenjuju ako ih promovišu građani sa jasnim stavovima; debata je jedan od **najsigurnijih modela** izgradnje modernog, ravnopravnog i tolerantnog društva.

> **Iz predavanja:** u debati se **učimo govorništvu i komunikaciji**, ne prekidamo sagovornika i ne koristimo uvrede ni bilo koji vid nasilja; debatom razvijamo svest o **konstruktivnom rešavanju problema**.

Zaključak: značaj govora i retorike u životu; vežbanjem razvijamo govorničke sposobnosti; razvijamo kritičko mišljenje, toleranciju, samopouzdanje i samopoštovanje. Citat: **„U naše vreme ima moć onaj koji zna govoriti" (R. C. Salisbury).**

Brojke, godine i autori

Sve brojke, godine i autori iz predmeta na jednom mestu; ponovi ih dan pred ispit.

Godine i autori

ŠTA	GODINA / AUTOR	LEKCIJA
Teorija životnog sistema (hijerarhija podsistema)	Miller	1
Zdravlje kao ravnoteža spoljne sredine i načina života	Hipokrat, oko 400. g. p. n. e.	1
Tradicionalna kineska medicina	pre oko 4.000 godina	1
7 bazičnih zdravih navika (Alameda studija)	Lester Breslow	1
Definicija narodnog zdravlja	Winslow	1
Model zdravstvenog verovanja (Health Belief Model)	Hochbaum (60-ih), razradio Rosenstock 1974.	2
Definicije ZV	Turner („Turne"), Wood, SZO	2
Alma-Ata, konferencija o PZZ	1978	3
Strategija zdravlja za sve u Evropi / Evropski ciljevi	1980 / 1984, 1991	3
Otava, promocija zdravlja (5 principa)	1986	3
Adelaida (4 prioriteta) / Beč, zdravi gradovi	1988 / 1988	3
Evropski dokument o okolini i zdravlju / Sundsvall	1990 / 1991	3
PRECEDE-PROCEED	Green, 1991	5
MHEP / CHEM	Ross i Mico, 1980 / Sullivan, 1973	5
MHERPD / CHEDS	Bates i Winden, 1984 / Patton, 1986	5
CINDI: početak u Evropskoj kancelariji SZO / u Jugoslaviji	1982 / 1986 (Beograd, Ljubljana, Novi Sad; DZ „Novi Sad")	5
Debata (format)	Karl Popper	6
„U naše vreme ima moć onaj koji zna govoriti"	R. C. Salisbury	6

Brojevi

ŠTA	BROJKA	LEKCIJA
Dimenzije zdravlja (ravnoteža, potencijal)	2	1
Dimenzije u merenju kvaliteta života	3	1
Dimenzije života (kvantitet, kvalitet)	2	1
Aspekti zdravlja	5	1
Grupe ljudi prema konstituciji (blizanci, TBC)	3	1
Bazične zdrave navike / sati sna	7 / 7–8	1
Oblici zdravstvenog ponašanja	4	2
Shvatanja u modelu zdravstvenog verovanja	3	2
Opšti ciljevi ZV (SZO) / specifični ciljevi	3 / 4	2
Indikatori zdravstvenog stanja	12	2
Vrednosti promocije zdravlja	5	3
Ciljevi PZ / ciljevi po UNESCO-u	4 / 6	3
Globalni / uži ciljevi ZV i PZ	3 / 4	3
Dokumenti SZO za PZ	7	3
Principi iz Otave / prioriteti iz Adelaide	5 / 4	3
Osnove za ZV dijagnozu	5	3
Faze ZV programa / elementi razrade u III fazi	5 / 7	4
Principi ZV programa	5	4
Mala grupa / velika grupa	10–15 / 30 i više	4
Izlaganje na predavanju	do 15 min	4
Tehnika Phillips	6 grupica, po 6 min	4
Zdravstveni filmovi	12–45 min	4
Pitanja u planiranju	3	4
Kategorije zdravstvenih indikatora / bazični elementi PZZ	4 / 8	4
Faze PRECEDE-PROCEED	9	5
Problemi koji se rešavaju ZV	9	5

ŠTA	BROJKA	LEKCIJA
Podoj u „bolnicama prijateljima dece"	pola sata posle rođenja	5
Savetovališta za decu	do 3 godine	5
Program odvikavanja od pušenja	petodnevni	5
Vrste rasprava	3	6
Koraci afirmacijske/negacijske linije / koraci pripreme	5 / 6	6
Karl Popperova debata	2 ekipe po 3 člana	6
Govori: uvodni / pitanja / završni	90 s / 60 s / 45 s	6
Osnovna škola u primeru debate	deca od 6 do 15 godina	6